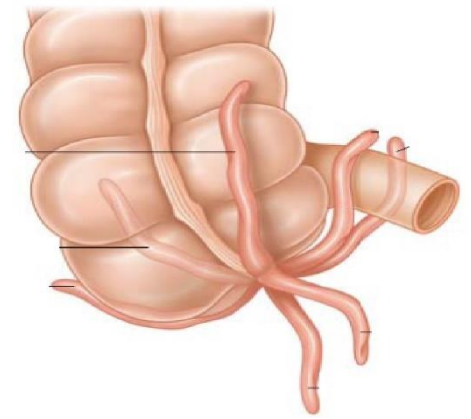
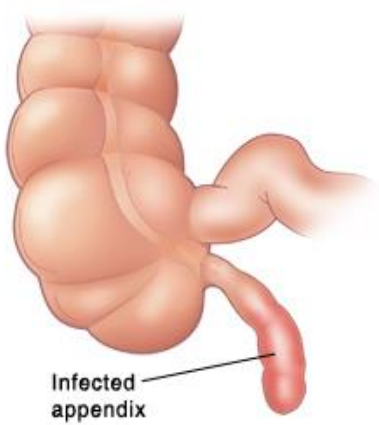




Appendicite aiguë

Signes – Diagnostic – Traitement

Dr Mamadou SECK

Maître - Assistant

Service de Chirurgie Générale, CHU Aristide Le Dantec, Dakar, Sénégal



Objectifs

- Définir l'appendicite aiguë
- Décrire les signes cliniques de l'appendicite aiguë
- Décrire les signes paracliniques de l'appendicite aiguë
- Décrire les complications de l'appendicite aiguë
- Donner les principes du traitement de l'appendicite aiguë

Généralités

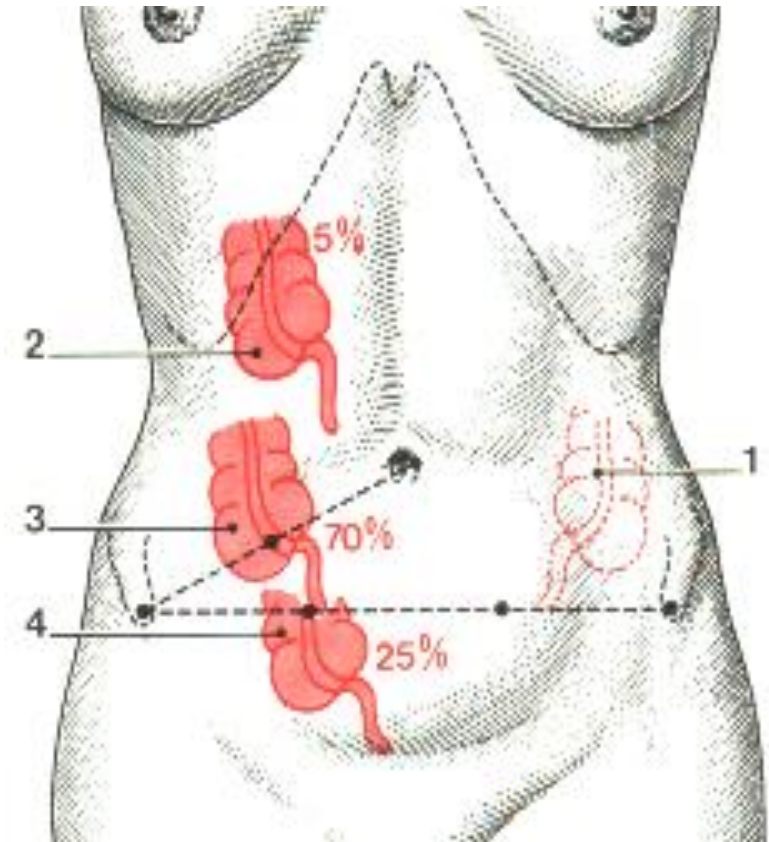
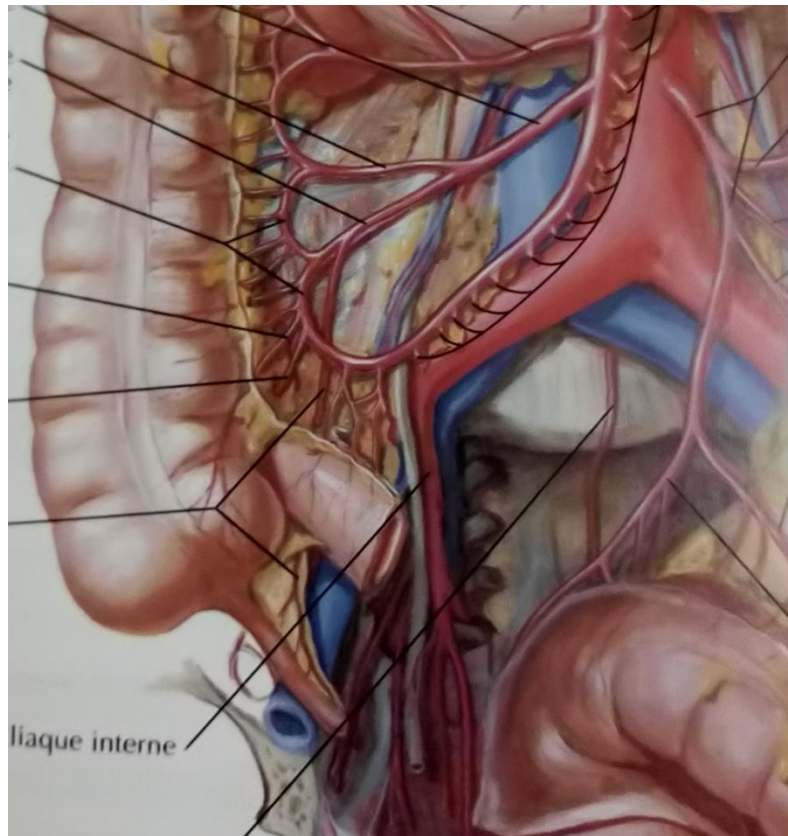
Définition

L'appendicite aiguë est une inflammation aiguë
de l'appendice iléo-caecal.

Intérêt

- Fréquence
- Diagnostic (Clinique +++; Echographie ++)
- Gravité des complications
- Traitement: chirurgical +++

Rappel anatomique



Anatomo-pathologie

- Appendicite catarrhale;
- Appendicite phlegmoneuse;
- Appendicite gangrenée;
- Appendicite perforée

Signes

TDD: Appendicite aiguë franche iliaque droite

- Signes cliniques

Signes fonctionnels

- Douleur : à début brutal parfois progressif, à type de colique, lancinante, paroxystique, sans facteurs déclenchants, siégeant à la fosse iliaque droite (FID), mais plus souvent initialement à l'épigastre ou en péri-ombilical
- Vomissements alimentaires puis bilieux souvent remplacés par des nausées
- Constipation parfois diarrhée

TDD: Appendicite aiguë franche iliaque droite

- **Signes cliniques**

Signes généraux

- Fièvre modérée à 38-38°5C
- Pouls accéléré (en rapport avec la température)
- Faciès angoissé avec langue saburrale
- Conservation de l'état général

TDD: Appendicite aiguë franche iliaque droite

- Signes cliniques

Signes physiques

Inspection : respiration abdominale normale

Palpation :

- douleur provoquée au point de **Mac BURNEY**.
- douleur à la décompression brusque de la FID (**signe de Blumberg**)
- douleur à la compression brusque de la fosse iliaque gauche (**signe de Rovsing**)
- douleur à la décompression brusque de la fosse iliaque gauche (**signe de Jacob**)

TDD: Appendicite aiguë franche iliaque droite

- Signes cliniques

Signes physiques

- défense de la FID : résistance tonique, douloureuse, involontaire qui peut être vaincue par la palpation douce.
- hyperesthésie cutanée de la FID, avec perte des réflexes cutanés abdominaux.

Touchers pelviens : douleur latéralisée à droite dans le cul-de-sac de Douglas .

Douleur provoquée au point de Mac Burney + défense FID + Hyperesthésie cutanée = **triade de Dieulafoy** (signe l'appendicite aigue)

TDD: Appendicite aiguë franche iliaque droite

- Signes paracliniques

Biologie: hyperleucocytose à PNN, VS accélérée, CRP positive.

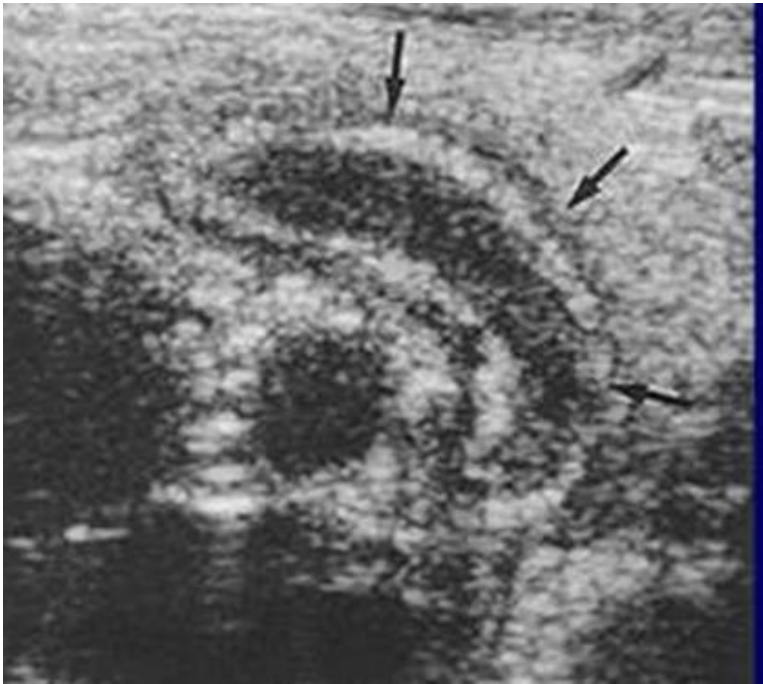
Imagerie

ASP : peu utile, peut montrer une anse sentinelle (niveau hydro-aérique du caecum ou de la dernière anse grêle) et/ou image de stercolithe.

Echographie abdominale : examen de **1^{ère} intention**.
Appendice non dépressible, épaissement pariétal > 3mm, diamètre appendiculaire > 6mm et contours irréguliers hypoéchogènes (aspect en cocarde).

TDM abdominale : examen de **référence**, plus performant que l'échographie. Epaissement et augmentation de taille de l'appendice et épaissement du méso. Recherche de complications.

Imagerie



Echographie



Scanner (Stercolithe)

TDD: Appendicite aiguë franche iliaque droite

- Evolution

- Éléments de surveillance

- Cliniques

- Constantes température+++, TA, Pouls

- Examen physique : évolution de la douleur et de la défense

- Paracliniques

- NFS, VS, échographie

- Modalités évolutives

- Sous traitement: favorable vers la guérison

- En l'absence de traitement: complications

Formes cliniques

- Formes symptomatiques

Formes atténuées : douleur vague de la FID, peu sensible à la palpation. Le diagnostic est fait à l'échographie ou au scanner.

Formes toxiques : signes généraux marqués avec tachycardie, hypotension artérielle voire collapsus cardio-vasculaire, oligurie.

L'évolution se fait souvent vers la mort en 24-48heures.

Formes cliniques

- Formes topographiques

Appendicite rétro-caecale : douleur plus postérieure, lombaire et parfois **psoriasis**.

Appendicite pelvienne : douleur basse, médiane, hypogastrique + signes urinaires (pollakiurie +++). Palpation de la fosse iliaque droite indolore.

Appendicite sous-hépatique : douleur de l'hypochondre droit simulant une cholécystite aigue. Echographie redresse le diagnostic

Appendicite mésocoeliale : appendice entre les anses grêles donnant un tableau d'OIA fébrile du grêle.

Formes cliniques

- Formes compliquées

Plastron appendiculaire: empâtement et blindage de la FID. Echographie ou TDM montre une agglutination d'anses grêles et de l'appendice dans un phénomène inflammatoire local.

Abcès appendiculaire: douleur vive et pulsatile de la FID, fièvre à 39°C, facies altéré, oligurie, TA basse, sueurs profuses, hyperleucocytose franche à PNN. Echographie ou TDM: collection hétérogène péri-appendiculaire.

Péritonite aigue généralisée: qui peut se faire en 1, 2 ou 3 temps.

Formes cliniques

Formes selon le terrain

Forme du sujet âgé ou de l'immunodéprimé : signes physiques sont pauvres, signes généraux (fièvre, anorexie, déshydratation) sont au premier plan donnant une dégradation rapide de l'état général.

Forme de la femme enceinte : le diagnostic est difficile durant les derniers mois (douleur haute, postérieure, simulant une pyélonéphrite aigue).

Forme de l'enfant : crise appendiculaire +/- typique mais fièvre élevée (39°C) et état général très rapidement altéré.

Forme du nourrisson : tableau de gastroentérite aigue fébrile

Diagnostic

Diagnostic positif

Clinique

Triade de Dieulafoy

Paraclinique

Echographie +++ et TDM abdominales

Diagnostic différentiel

Affections urinaires

- Colique néphrétique

- Pyélonéphrite aiguë

Affections gynécologiques

- Grossesse extra utérine

- Torsion d'annexes (ovaires et trompes)

Affections digestives

- Cholécystite aiguë

- Pancréatite aiguë

- Occlusion intestinale aiguë

- Perforation d'ulcère gastroduodénal

Diagnostic différentiel

Adénolymphite mésentérique

Antécédent récent de rhinopharyngite

Fièvre à 39°C

Absence de défense

Echographie: plusieurs adénopathies douloureuses

Diagnostic étiologique

Causes obstructives

- Stercolithe
- Hyperplasie lymphoïde
- Tumeur (Mucocèle, Tumeur carcinoïde, ADK,...)
- Parasites (Ascaris)
- Corps étranger

Causes hématogènes (Bactériémie)

Traitement

But

Juguler la crise

Enlever l'appendice

Prévenir les complications, le cas échéant les traiter

Moyens et méthodes

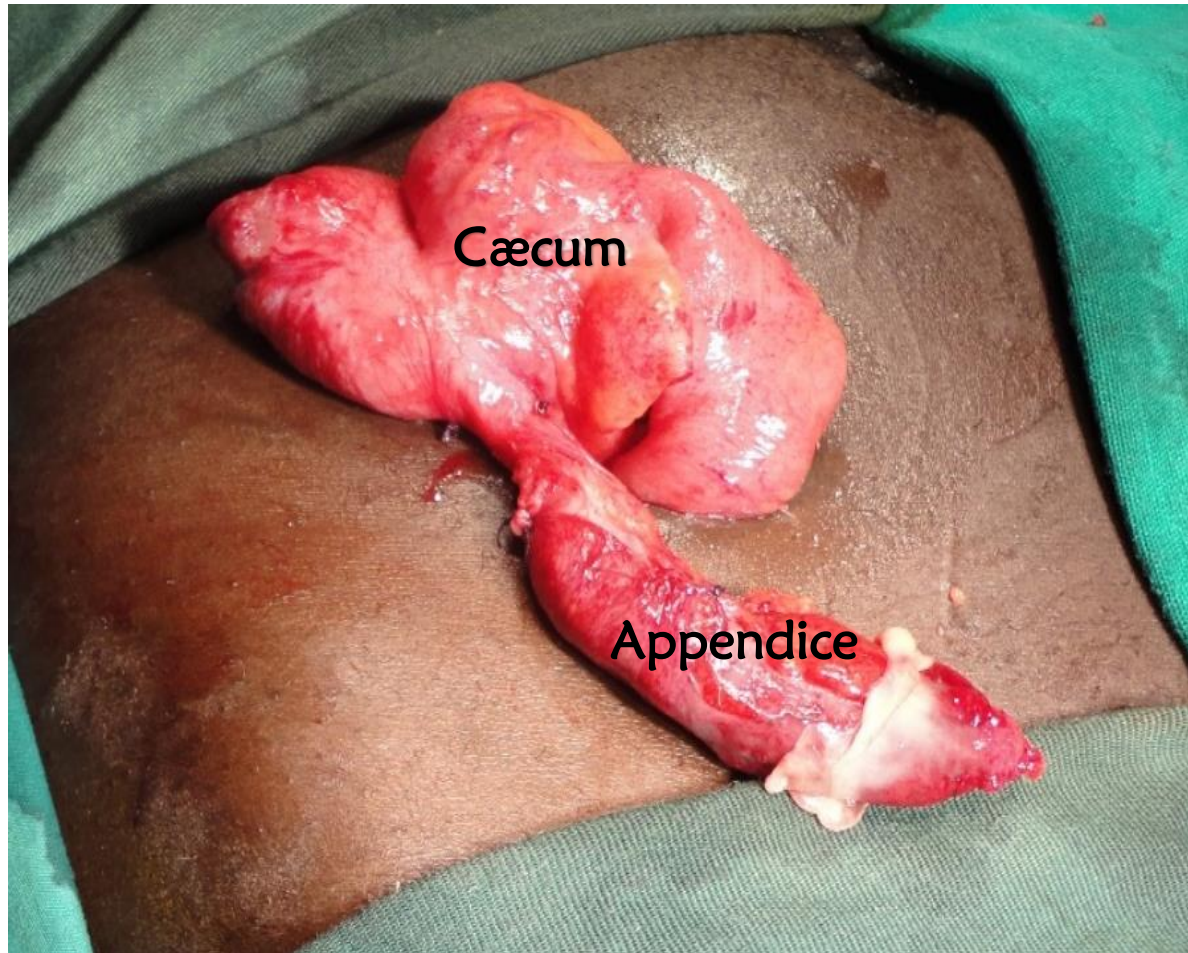
Médicaux

- Réanimation (arrêt alimentation, SNC, remplissage vasculaire)
- Antalgiques
- Antibiotiques à large spectre (amox-ac.clavulanique et aminosides).

Chirurgicaux

- Appendicectomie par laparotomie ou laparoscopie
- Toilette de la cavité péritonéale
- Drainage d'abcès

Vue opératoire



Appendice phlegmoneux

Indications

Appendicite aiguë : appendicectomie (Coelioscopie +++)

Plaçon appendiculaire : traitement médical puis chirurgie à froid

environ 2mois plus tard

Abcès appendiculaire : appendicectomie et drainage

Péritonite appendiculaire : appendicectomie avec toilette péritonéale

NB : toujours envoyer la pièce opératoire en anatomie pathologique.

Conclusion

- Urgence chirurgicale fréquente;
- Diagnostic clinique +++;
- Echographie : 1^{ère} intention ;
- Complications graves;
- Traitement chirurgical (Anatomie pathologique de la pièce +++)